

Rapport de Situation de la 17^e Épidémie de la maladie à Virus EBOLA /RDC
SitRep N°127/MVEBDB/18/09/2026

📅 Date de rapportage : 18 septembre 2026

📅 Date de publication : 19 septembre 2026


FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

Évolution globalement favorable par rapport au 11 septembre : baisse de 19,8 % des nouveaux cas (73 contre 91) et de 21,9 % des décès communautaires (25 contre 32). Toutefois, une remontée des cas (+10,6 %) et des décès communautaires est observée par rapport à la veille, malgré une baisse des décès intra-CTE (18 à 12). L'atteinte de la ZS de Dungu au Haut-Uélé constitue le principal signal d'alerte géographique et nécessite une intensification immédiate des interventions pour prévenir l'établissement de nouvelles chaînes de transmission.

CUMUL DES CAS

7 614
CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS

3 676
LETALITE

48,3%
PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE

909
CUMUL DES GUÉRIS

1 864
TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)

87,8%

Provinces touchées et Zones de santé touchées

5 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo et Bas-Uélé


55 Zones de santé touchées sur 117 (47%)
Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Au **18 septembre 2026**, la dynamique épidémiologique demeure **globalement plus favorable qu'au 11 septembre**, avec **73 nouveaux cas confirmés contre 91**, soit une **baisse de 19,8 %**. Cette amélioration est particulièrement marquée au **Nord-Kivu**, où les nouveaux cas sont passés de **50 à 18 (-64,0 %)**. Toutefois, par rapport à la veille, une **remontée de 10,6 %** des nouveaux cas est observée (**73 contre 66**), principalement portée par l'Ituri, qui passe de **37 à 46 cas**. Les 73 nouveaux cas du jour ont été rapportés en **Ituri (46)**, au **Nord-Kivu (18)**, au **Haut-Uélé (6)** et dans la **Tshopo (3)**.

La mortalité présente également une **amélioration par rapport au 11 septembre**, avec **37 décès contre 39 (-5,1 %)**. Les **décès communautaires diminuent de 32 à 25 (-21,9 %)** par rapport au 11 septembre, constituant un progrès à consolider. Néanmoins, une remontée des décès communautaires est observée par rapport à la veille (**25 contre 16**). En revanche, les **décès intra-CTE diminuent de 18 à 12 (-33,3 %) en 24 heures**, dont 10 en Ituri et 2 au Nord-Kivu.

La prise en charge enregistre un **progrès notable**, avec **41 patients déclarés guéris**, contre **25 la veille**, soit une **augmentation de 64,0 %** des guérisons en 24 heures. Ces guérisons ont été rapportées en **Ituri (30)**, au **Haut-Uélé (6)**, au **Nord-Kivu (3)** et dans la **Tshopo (2)**. Ce résultat favorable mérite d'être consolidé parallèlement aux efforts visant à réduire les décès communautaires et intra-CTE.

Sur le plan géographique, une **nouvelle Zone de Santé, Dungu dans la province du Haut-Uélé, a été touchée au cours de la journée**, alors qu'aucune nouvelle ZS n'avait été affectée la veille ni le 11 septembre. Cette extension constitue le **principal point d'attention géographique**. La situation de Dungu, frontalière du Soudan du Sud, nécessite un **renforcement immédiat de la surveillance transfrontalière**, de l'investigation autour des cas, du suivi des contacts, de la surveillance aux PoE/PoC et de l'engagement communautaire afin de prévenir l'établissement de nouvelles chaînes de transmission.

Depuis le début de l'épidémie, la RDC totalise **7 614 cas confirmés et 3 676 décès**, soit une **létalité de 48,3 %**. L'**Ituri demeure l'épicentre**, concentrant **77,2 % des cas confirmés cumulés** et **63,0 % des nouveaux cas du jour**, ce qui justifie le maintien d'une forte intensité des interventions dans les foyers actifs.

Concernant l'étendue géographique, l'intégration de **Dungu comme nouvelle ZS affectée doit porter le nombre de ZS actuellement affectées de 54 à 55**, sous réserve de la réconciliation de la ventilation provinciale. En effet, la ventilation initialement rapportée (**25 en Ituri, 15 au Nord-Kivu, 6 au Haut-Uélé, 6 dans la Tshopo et 3 au Bas-Uélé**) totalise déjà **55 ZS**. Il convient donc de **réconcilier le dénominateur et la ventilation par province avant publication**, notamment pour confirmer si Dungu est déjà comprise parmi les ZS du Haut-Uélé et préciser le nombre actuel de ZS affectées dans la Tshopo.

Enfin, le **Sud-Ubangi demeure sous surveillance renforcée**. Le cas détecté dans la ZS de Bulu reste considéré comme importé et **aucune transmission locale secondaire n'est documentée à ce stade**. Cette situation constitue un **signal favorable à préserver** par le maintien d'une surveillance sensible, d'un suivi rigoureux des contacts et d'une capacité de détection précoce de toute éventuelle transmission secondaire.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province et situation des zones de santé, au 18 septembre 2026

Province	Nouveaux cas confirmés (24 h)	Cas confirmés cumulés	Décès confirmés cumulés	Létalité	ZS historiquement touchées	ZS actuellement affectées*
Ituri	46	5 875	2 688	45,8 %	28/36	25/36
Nord-Kivu	18	1 388	843	60,7 %	16/34	15/34
Haut-Uélé	6	302	126	41,7 %	7/13	7/13
Tshopo	3	38	13	34,2 %	7/23	5/23
Sud-Kivu	0	3	1	33,3 %	1/34	0/34
Bas-Uélé	0	7	4	57,1 %	3/11	3/11
Sud-Ubangi**	0	1	1	100,0 %	1/16	—
Total	73	7 614	3 676	48,3 %	63/167 (37,7 %)	55 ZS dans 5 provinces

* ZS actuellement affectées : zones de santé n'ayant pas encore franchi le seuil de 42 jours sans nouveau cas confirmé.

** Sud-Ubangi : le cas de la ZS de Bulu demeure considéré comme importé ; aucune transmission locale secondaire n'est documentée à ce stade.

Au **18 septembre 2026**, la transmission demeure fortement concentrée en **Ituri et au Nord-Kivu**, qui totalisent **64 des 73 nouveaux cas (87,7 %)**. L'Ituri reste l'épicentre, avec **77,2 % des cas cumulés et 63,0 % des nouveaux cas du jour**, tandis que le Nord-Kivu conserve une **létalité élevée de 60,7 %**. L'atteinte de la **ZS de Dungu** porte à **7/13** le nombre de ZS historiquement touchées et actuellement affectées au Haut-Uélé, traduisant une extension géographique nécessitant le renforcement des interventions, notamment de la surveillance transfrontalière. Au total, **55 ZS dans cinq provinces demeurent actuellement affectées**, contre 63 ZS historiquement touchées. L'absence de nouveau cas au **Sud-Kivu, Bas-Uélé et Sud-Ubangi** constitue un signal favorable à consolider par le maintien d'une surveillance sensible.

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	5875	2688	45,8%	46	17	10	27
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	187	39	20,9%	1	0		0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1646	513	31,2%	11	1		1
Damas	40	9	22,5%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	80	30	37,5%				0
Gethy	7	3	42,9%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	34	12	35,3%				0
Komanda	146	89	61,0%	5	1		1
Lita	272	135	49,6%	3	2		2
Logo	13	5	38,5%				0
Lolwa	31	8	25,8%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	21	9	42,9%				0
Mandima	59	33	55,9%				0

Mangala	331	146	44,1%	5	0		0
Mongbwalu	679	315	46,4%	3	3		3
Nia-Nia	262	140	53,4%	9	8		8
Nizi	749	274	36,6%	1	0		0
Nyankunde	126	36	28,6%	1	0		0
Rimba	12	4	33,3%				0
Rwampara	1043	352	33,7%	7	2		2
Tchomia	75	25	33,3%				0
A ventiler	NA	487	NA			10	10
Nord-Kivu	1388	843	60,7%	18	4	2	6
Beni	271	186	68,6%	8	0		0
Biena	18	7	38,9%				0
Butembo	249	161	64,7%	3	0	1	1
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	41	14	34,1%	1	0	1	1
Katwa	540	342	63,3%	2	2		2
Kayna	1	0	0,0%				0
Kyondo	32	20	62,5%				0
Lubero	15	7	46,7%				0
Mabalako	24	11	45,8%	1	1		1
Manguredjipa	10	3	30,0%				0
Masereka	24	9	37,5%				0
Musienene	120	65	54,2%	1	1		1
Mutwanga	8	2	25,0%				0
Oicha	13	10	76,9%	1	0		0
Vuhovi	21	6	28,6%	1	0		0
Haut-Uélé	302	126	41,7%	6	3	0	3
Boma Mangbetu	36	15	41,7%	1	0		0
Dungu	1	1	100,0%	1	1		1
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	98	42	42,9%				0
Pawa	67	32	47,8%	4	2		2
Rungu	2	1	50,0%				0
Wamba	95	34	35,8%				0
Tshopo	38	13	34,2%	3	1	0	1
Bafwasende	7	1	14,3%				0
Kabondo	5	1	20,0%	1	0		0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	19	8	42,1%	2	1		1
Mangobo	4	2	50,0%				0
Tshopo	1	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas-Uélé	7	4	57,1%	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	3	1	33,3%				0

Ganga	3	2	66,7%				0
Sud Ubangi	1	1	100,0%	0	0	0	0
Bulu	1	1	100,0%				0
Total	7614	3676	48,3%	73	25	12	37

Au 18 septembre 2026, la transmission demeure principalement concentrée en **Ituri et au Nord-Kivu**, qui totalisent **64 des 73 nouveaux cas (87,7 %)**. En Ituri, l'activité est particulièrement marquée à **Bunia (11 cas)**, **Nia-Nia (9)**, **Rwampara (7)**, **Komanda et Mangala (5 cas chacun)**, tandis qu'au Nord-Kivu, **Beni concentre 8 des 18 nouveaux cas**. Le **Haut-Uélé rapporte 6 cas**, dont le premier cas confirmé à **Dungu**, nouvelle ZS touchée, et la Tshopo enregistre 3 cas. La mortalité reste préoccupante avec **37 décès en 24 heures, dont 25 communautaires et 12 intra-CTE**, appelant au renforcement de la détection précoce, du référencement et de la prise en charge dans les foyers actifs.

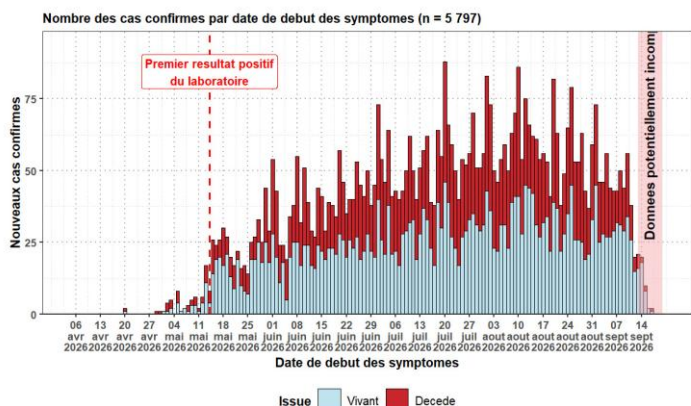
Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 18 septembre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CTE/CT (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	45	4	49	19	3	24	1	22	9
Bas-Uélé	74	2	76	7	2	66	0	9	0
Ituri	1 108	92	1200	143	89	667	2	232	118
Nord-Kivu	373	24	397	62	24	255	0	86	52
Sud Ubangi	45	5	50	3	0	0	0	3	1
Tshopo	75	5	80	5	3	72	0	8	3
Total Général	1 720	132	1 852	239	121	1 084	3	360	183

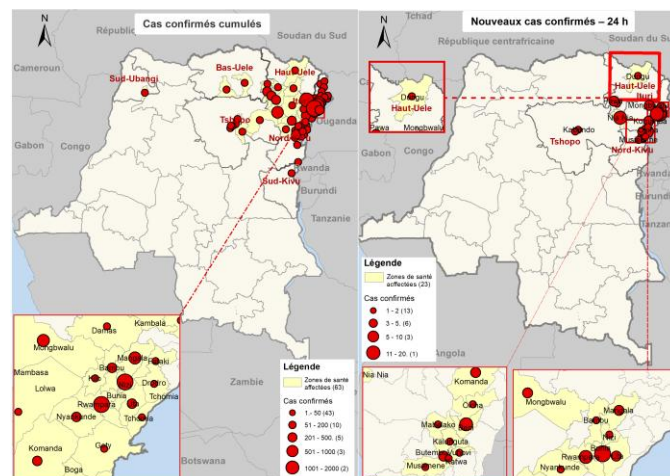
La surveillance maintient une bonne performance dans l'investigation, avec 100 % des 360 cas suspects investigués. Toutefois, le taux global de vérification des alertes reste à améliorer (78,1 %), de même que le référencement des suspects vers les CTE/CT (183/360 ; 50,8 %). Une attention particulière doit être accordée à l'Ituri, qui concentre près des deux tiers des alertes et des suspects.

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours

Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24h et cumuls) par zone de santé.



Source : DHIS2 Tracker - Riposte MVE, septembre 2026. Données incluses : cas confirmés avec statut vital et date de début de symptômes renseignés, n = 5 797.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- **Suivi et accompagnement des interventions de la riposte dans l'ensemble des provinces touchées**, avec une attention particulière aux zones de santé à transmission active et aux nouveaux foyers, notamment la **ZS de Dungu au Haut-Uélé**.
- **Finalisation du préparatif du lancement officiel de la vaccination par ERVEBO en Ituri**
- **Renforcement de l'analyse intégrée des données de la riposte**, en vue de mieux identifier les goulots d'étranglement entre surveillance, laboratoire, PEC, PCI/EDS, CREC, logistique et gestion des données.

1.2. Défi majeur

- Assurer une coordination réactive et intégrée des interventions dans l'ensemble des foyers actifs, notamment face à l'extension de la transmission à la ZS de Dungu, tout en garantissant la réussite opérationnelle du lancement de la vaccination par ERVEBO et en renforçant l'exploitation inter-piliers des données pour identifier rapidement les goulots d'étranglement et orienter les actions correctives prioritaires.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Au regard des données rapportées, **1 852 alertes** ont été remontées, dont **1 447 (78,1%)** ont été vérifiées. Parmi celles-ci, **360 alertes ont été validées comme cas suspects**. L'ensemble de ces cas suspects (100 %) ont fait l'objet d'une investigation, et **183** ont été transférés vers les CT/CTE ([Tableau 3](#)).

Au cours des dernières 24 heures, **26 803 ont été vus parmi les 30 541 contacts** en cours de suivi, soit une proportion de suivi de **87,8%**, stable par rapport à la veille (87,2%). Cette proportion était de 100,0% (42/42) au Sud Ubangi, 94,0% (13 964/14 861) en Ituri, 91,5% (193/211) au Bas-Uélé, 82,2 % (11 345/13 801) au Nord-Kivu, 78,0% (981/1 257) au Haut-Uélé et 75,3 % (278/369) à la Tshopo.

2.1.2. Défi majeur

Améliorer la réactivité de la surveillance sur l'ensemble de la cascade alerte–vérification–investigation–référencement, notamment en relevant le taux de vérification des alertes, actuellement à 78,1 %, et en assurant le référencement approprié des cas suspects vers les CT/CTE. Parallèlement, renforcer le suivi des contacts dans les provinces encore en dessous du niveau national de 87,8 %, particulièrement dans la Tshopo (75,3 %), le Haut-Uélé (78,0 %) et le Nord-Kivu (82,2 %), afin de réduire le risque de contacts perdus de vue et de détecter précocement toute nouvelle chaîne de transmission.

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Six (6) alertes ont été notifiées aux différents PoE/PoC des cinq provinces suivies au cours des dernières 24 heures. Quatre (4) alertes étaient rapportées en Ituri et deux (2) au Nord-Kivu ; toutes les alertes validées ont été investiguées dans les 24 heures (100 % ; 5/5) et trois ont été transférées vers les CT/CTE (60,0 % ; 3/5).

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 18 septembre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Global
Complétude des rapports	95,0% (57/60)	100% (20/20)	55,6% (5/9)	100% (18/18)	71,4% (5/7)	92,1% (105/114)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	146 383	93 658	8 152	19 745	13 207	281 145
% des voyageurs screenés	96,0%	97,7%	98,5%	99,3%	99,0%	97,0%
% des voyageurs ayant lavé les mains	96,0%	97,7%	98,7%	99,2%	99,0%	97,0%

% des voyageurs sensibilisés	99,0%	97,7%	100,0%	100,0%	100,0%	98,7%
Nombre d'alertes notifiées	4	2	0	0	0	6
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	3	2	0	0	0	5
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	0	0	0	0
% des cas suspects transférés au CTE/CT	33,3% (1/3)	100% (2/2)	NA	NA	NA	60,0% (3/5)
% des corps sans vie swabés/sécurisés	NA	NA	NA	NA	NA	NA
% des cas suspects investigués dans 24 h	100% (3/3)	100% (2/2)	NA	NA	NA	100% (5/5)

2.2.2. Défis

Renforcer la capacité des PoE/PoC à détecter, valider, investiguer et référer rapidement les alertes, tout en améliorant le transfert effectif des cas suspects vers les CT/CTE. Une attention particulière doit être accordée aux corridors à forte mobilité afin de limiter le risque de propagation inter-zones et interprovinciale et de contribuer à l'interruption des chaînes de transmission.

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 46 nouveaux résultats positifs** (29 vivants et 17 décès) sur 200 nouveaux échantillons reçus et analysés (**positivité : 23,0%**).
- **Nord-Kivu : 18 échantillons résultats positifs** (14 vivants et 4 décès) sur 116 échantillons analysés (**positivité de 15,5%**).
- **Haut-Uélé : 6 nouveaux résultats positifs** (3 vivants et 3 décès) sur 34 échantillons reçus et analysés au laboratoire d'Isiro (**positivité : 17,6%**).
- **Tshopo : 3 nouveaux résultats positifs (2 vivants et 1 décès) sur 6 échantillons reçus et testés (positivité : 50%)**.
- **Bas-Uélé** : 4 échantillons reçus et analysés (4 vivants) tous se sont révélés négatifs.
- **Sud Ubangi** : les échantillons prélevés autour des deux décès communautaires signalés ont été acheminés à l'INRB et les résultats sont attendus.

2.3.2. Défi majeur

Maintenir la capacité de diagnostic biologique et réduire les délais sur l'ensemble de la chaîne prélèvement–acheminement–analyse–restitution des résultats, dans un contexte de circulation virale toujours active. Une vigilance renforcée est requise dans la Tshopo, où la positivité atteint 50,0 %, ainsi qu'en Ituri (23,0 %), au Haut-Uélé (17,6 %) et au Nord-Kivu (15,5 %).

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 27 rings ont été ouverts, soit un taux d'ouverture de 61,3 %, et 69 ménages ont été décontaminés sur les 72 identifiés (95,8 %) ; 13 FOSA ont été décontaminées, sans dotation de kits d'hygiène aux ménages ni aux écoles au cours des dernières 24 heures. Quant aux EDS, 104 alertes ont été enregistrées, 80 EDS réalisés (76,9 %) et 69 corps swabés sur 80 (86,3 %).
- **Au Nord-Kivu**, 31 rings ont été ouverts sur les 40 attendus (77,5 %), 5 ménages décontaminés sur 15 identifiés (33,3 %) et 24 FOSA décontaminées sur 29 (82,8 %) ; aucun kit PCI n'a été doté aux ménages des cas et 12 évaluations score-card ont été réalisées, avec un score moyen de 17,6 % ; 19 FOSA évaluées, 279 accompagnées, 879 prestataires briefés, 180 dispositifs de lavage des mains suivis, 3 unités de triage installées et 10 600 litres d'eau fournis aux lieux publics. Quant aux EDS, 53 EDS réalisés et 42 corps swabés sur 44 (95,5 %).
- **À la Tshopo**, deuxième journée de la formation des 95 PPL des ZS de Kabondo et de Makiso-Kisangani ; évaluation du risque d'exposition des PPL de la DHK (10 à haut risque, 14 à risque faible et 3 à risque indéterminé) ; décontamination des HGR de Makiso-Kisangani et de Mangobo ainsi que de six locaux de deux ménages ; suivi et accompagnement de 13 ESS dans les 6 zones de santé avec 139 prestataires briefés. Quant aux EDS, 1 corps sans vie a été swabé à la morgue de Rekapi.

- **Au Haut-Uélé**, 6 rings ont été ouverts sur les 6 attendus (100 %) et 7 ménages ont été décontaminés ; 17 alertes PCI ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures. Quant aux EDS, 4 alertes ont été enregistrées, 4 EDS réalisés (100 %) et 4 corps swabés (100 %).
- **Au Bas-Uélé**, poursuite de la formation des 6 prestataires des 3 PoC de la ZS de Buta avec l'appui de FHI 360 et de l'accompagnement des ESS des ZS d'Ango, de Monga et de Ganga.
- **Au Sud Ubangi**, 1 ménage a été décontaminé sur les 2 identifiés (50,0 %) dans l'aire de santé de Gwaka, sans ring ouvert ni FOSA décontaminée ; suivi et accompagnement des prestataires des CS de Kuma et d'Akula et briefing in situ de 2 techniciens de laboratoire et de 10 hygiénistes sur le port et le retrait des EPI, le prélèvement chez les décès suspects et l'EDS. Quant aux EDS, 2 alertes ont été enregistrées, 1 EDS réalisé et 1 corps swabé

2.4.2. Défis

Améliorer la couverture et la rapidité des interventions PCI/EDS autour de chaque cas et décès afin de réduire les risques de transmission nosocomiale et communautaire. Les priorités portent notamment sur l'augmentation de l'ouverture des rings en Ituri (61,3 %), l'accélération de la décontamination des ménages au Nord-Kivu (33,3 %) et au Sud-Ubangi (50,0 %), ainsi que le renforcement des performances PCI dans les FOSA, particulièrement au Nord-Kivu où le score moyen des évaluations reste faible (17,6 %). Il convient également de consolider la réalisation des EDS et le prélèvement systématique des corps, tout en maintenant les bonnes performances observées au Haut-Uélé.

2.5. Prise en charge holistique

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 102 nouvelles admissions enregistrées au décours de la journée contre 98 sorties dont 30 guéries. Ainsi, 434 patients sont hospitalisés pour 1015 lits, soit un taux d'occupation de 42,8 % ; 390/421 (92,6 %) patients ont bénéficié d'un repas chaud ; 7/7 enfants sont sous LNPE/SLM au CTE, 4/4 à la crèche et 25/25 dans la communauté ; 40 malades sont en état critique et 22 patients ont été évacués au cours des 17/33 mouvements d'ambulances rapportés.
- **Au Nord-Kivu**, 70 nouvelles admissions enregistrées contre 69 sorties dont 3 guéries ; 392 patients sont hospitalisés dont 224 dans les structures normées avec une capacité d'accueil de 228 lits, soit un taux d'occupation global de 98,2 %, proche de la saturation. 4/4 accompagnants et 77/77 prestataires de première ligne ont bénéficié de repas chauds, 11/11 nourrissons séparés sont sous LNPE/SLM, 3 enfants sont suivis en crèche et 20/20 ménages de patients ont reçu un soutien alimentaire ; 18 courses d'ambulance ont été réalisées et toutes réussies (100 %).; 11 malades sont en état critique.
- **Au Haut-Uélé**, 14 nouvelles admissions ont été enregistrées dans les structures contre 16 sorties (6 guéries). Ainsi, 63 patients sont hospitalisés pour 138 lits, soit un taux d'occupation de 45,7 % ; 30 confirmés, 30 suspects, 79 accompagnants et 36 PPL ont bénéficié de repas chauds ; 9 courses d'ambulance ont été réalisées pour 9 patients transportés.
- **Au Bas-Uélé**, 1 nouvelle admission rapportée ; 10 patients demeurent en isolement dont 1 cas confirmé pris en charge à l'HGR de Ganga ; 9 contacts à haut risque demeurent sous prophylaxie et 10 sont sortis indemnes du suivi.
- **À la Tshopo**, 2 nouvelles admissions enregistrées contre 4 sorties dont 2 guéris et 2 non-cas. Dix (10) patients sont en isolement pour 31 lits, soit un taux d'occupation de 32,3 % ; 8 confirmés et 1 suspect ont bénéficié d'un repas chaud et 42/42 (100 %) prestataires de première ligne ont été servis.

2.5.2. Défis

Prévenir la saturation des capacités de prise en charge, particulièrement au Nord-Kivu où les structures normées atteignent un taux d'occupation de 98,2 %, tout en garantissant la qualité et la continuité des soins. Une attention prioritaire doit également être accordée à la prise en charge précoce des formes graves, avec 40 patients en état critique en Ituri et 11 au Nord-Kivu, au renforcement du référencement et des évacuations médicales, ainsi qu'au maintien des interventions nutritionnelles, psychosociales et prophylactiques autour des patients et personnes à haut risque.

2.6. Vaccination & Prophylaxie Post-exposition

2.6.1. Principales actions

- **À la Tshopo**, 3 369 personnes ont été vaccinées à ce jour sur 11 703 TPL/PPL ciblés (28,8 %), dont 1 830 à Makiso-Kisangani, 466 à Kabondo, 422 à Mangobo, 316 à Tshopo, 173 à

Bafwasende et 162 à Lubunga ; le stock disponible au dépôt Hub s'élève à 500 doses congelées et 631 doses décongelées expirant le 24 septembre 2026 ;

- **En Ituri**, poursuite des préparatifs du lancement officiel de la campagne de vaccination des PPL, prévu le 19 septembre 2026 au Grand Laboratoire de Bunia avec l'appui de MSF ; le site de lancement est prêt ;
- **Au Bas-Uélé**, la vaccination compassionnelle se poursuit à Ganga et l'acheminement de la chaîne ultra-froide vers l'antenne PEV de Buta reste en cours. Au Nord-Kivu, réception des équipements de la chaîne de froid en préparation de la campagne de vaccination : 2 réfrigérateurs, 2 congélateurs, 1 stabilisateur et 10 porte-vaccins. **En Ituri**, poursuite des préparatifs de la vaccination des PPL ;
- **À la Tshopo**, 146 cas ont reçu le traitement expérimental, dont 19 confirmés et 127 sous prophylaxie post-exposition (92 terminés, 11 interrompus et 24 en cours) ; les 7e et 8e PPL ont été confirmés positifs et au moins 88 % des PPL de l'ESS visitée sont vaccinés (21/24) ; une revue de décès maternel par éclampsie a été organisée par le bureau central de la zone de santé ;
- **Au Bas-Uélé**, poursuite de la sensibilisation des contacts pour l'adhésion à la prophylaxie compassionnelle à Viadana et de la recherche des contacts jamais vus, au 35e jour à Buta et au 23e jour à Ganga, à Poko et à Viadana.

2.6.2. Défis

Accélérer et harmoniser le déploiement de la vaccination et de la prophylaxie post-exposition dans les provinces affectées, tout en garantissant la disponibilité et la gestion optimale des vaccins et de la chaîne du froid. Une attention particulière doit être portée à l'amélioration de la couverture vaccinale des TPL/PPL à la Tshopo, encore limitée à 28,8 %, à l'utilisation diligente des 631 doses décongelées avant leur expiration le 24 septembre, ainsi qu'au démarrage effectif de la vaccination en Ituri et au Nord-Kivu. Il convient également de renforcer l'adhésion, le suivi et la complétude de la prophylaxie post-exposition, notamment pour réduire les interruptions de traitement et assurer la protection rapide des personnes exposées.

2.7. Communication sur les risques et engagement communautaire

2.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, 17 802 visites à domicile ont touché 81 306 personnes et 164 causeries éducatives ont touché 748 personnes ; 12 sensibilisations de masse ont touché 2 496 personnes, 9 débats communautaires 208 personnes et 9 plaidoyers 14 personnes ; 217 alertes communautaires ont été notifiées (dont 51 décès), 48 des 68 feedbacks ont été résolus dans les 48 heures et 26 des 36 incidents communautaires également ; 60 spots de sensibilisation ont été diffusés dans 15 stations de radio ; la complétude du rapportage demeure faible (39 % ; 11/28 ZS) ;
- **Au Nord-Kivu**, 10 508 visites à domicile ont touché 29 430 personnes et 139 causeries éducatives 3 363 personnes ; 9 actions de communication de masse ont touché 1 188 personnes et 3 briefings 112 personnes, tandis que 397 élèves et 49 enseignants ont été sensibilisés ; 300 alertes communautaires ont été notifiées sur 450 attendues (67 %), 11 feedbacks résolus sur 16 (69 %), 1 incident résolu sur 6 (16,7 %) et 1 205 personnes engagées sur 4 750 (25 %) ; un dialogue communautaire a réuni 104 leaders d'opinion à Manguredjipa autour de la réinsertion du premier guéri de la zone et la sortie de 4 guéris du CTE de Beni a été médiatisée ; la couverture demeure de 10 ZS sur 14 attendues (71,4 %) ;
- **Au Haut-Uélé**, 13 activités d'engagement communautaire ont touché 275 personnes (101 hommes et 174 femmes) et les actions menées autour du dernier cas confirmé de Viadana ont touché 7 personnes ; 21 alertes de cas suspects sur 160 attendues (13,1 %) et 4 alertes de décès communautaires (2,5 %) ont été notifiées par les acteurs communautaires, 11 feedbacks ont été résolus dans les 48 heures et 1 incident sur 98 (1,0 %) ;
- **À la Tshopo**, 3 activités de sensibilisation de masse ont touché 1 978 personnes (1 081 hommes et 897 femmes), 129 affiches et 5 banderoles ont été distribuées et 4 émissions radiophoniques diffusées ; 4 alertes communautaires ont été notifiées et toutes résolues, ainsi que 2 feedbacks dans les 48 heures ;
- **Au Sud Ubangi**, 358 visites à domicile ont touché 1 790 personnes (806 hommes et 984 femmes) dans les aires de santé de Gwaka, de Kuma et d'Akula ; aucune alerte communautaire n'a été notifiée et la CREC a appuyé les piliers surveillance, laboratoire, PCI et EDS autour du décès communautaire d'Akula ainsi que l'accompagnement psychosocial de la famille du cas confirmé en isolement.

2.7.2. Défis

Renforcer la capacité de la CREC à transformer la forte mobilisation communautaire en détection précoce, remontée des alertes et résolution rapide des feedbacks et incidents. Les priorités concernent l'amélioration de la complétude du rapportage en Ituri (39 %), de la couverture des zones de santé et de la résolution des incidents au Nord-Kivu (16,7 %), ainsi que le renforcement substantiel de la notification des alertes et de la gestion des incidents au Haut-Uélé, où seulement 13,1 % des alertes attendues et 1,0 % des incidents ont été rapportés/résolus. Il convient également de maintenir une communication de proximité ciblée dans les nouveaux foyers et autour des décès communautaires afin de favoriser l'adhésion aux interventions et de prévenir les résistances communautaires.

2.8. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.8.1. Principales actions

- **En Ituri**, 90 des 141 cas confirmés en cours de suivi (63,8 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 28 des 97 nouveaux suspects (28,9 %) et 124 des 141 suspects en cours de suivi (87,9 %) ; 88 annonces de résultats dont 32 positifs, 288 accompagnants et 50 PPL soutenus, 9/9 enfants suivis en crèche, 17/21 guéris suivis en communauté, 11 des 14 ménages d'enfants séparés et orphelins accompagnés (34 enfants suivis) et 9 des 30 guéris réinsérés ; déploiement de 24 APS/TPS formés dans les ZS de Nizi, de Bambu, de Lita et de Nyankunde ;
- **Au Nord-Kivu**, 20 personnes parmi les nouveaux cas confirmés et 215 cas confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 217 nouveaux suspects et 276 suspects en cours de suivi ; 113 annonces de résultats dont 27 positifs, 78 ménages accompagnés et 77 PPL soutenus, 10/10 guéris réinsérés et suivis en communauté, 41/41 enfants suivis dans la communauté, 3/3 en crèche et 20/20 ménages d'enfants séparés et orphelins accompagnés ; 125 hommes, 178 femmes et 69 enfants ont bénéficié de séances de psychoéducation avec l'appui de l'UNICEF et les 8 zones de santé ayant notifié sont toutes couvertes (100 %) ;
- **À la Tshopo**, 4 des 5 derniers cas confirmés (80 %) et 2/2 cas confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 1/1 nouveau suspect et 2/2 suspects en cours de suivi ; 6 annonces de résultats dont 5 positives, 8 ménages accompagnés, 1 PPL soutenu, 2/2 guéris suivis en communauté et 2 des 3 résistances brisées dans la ZS de Kabondo ; 3 des 4 zones de santé ayant notifié sont couvertes (75,0 %) ;
- **Au Haut-Uélé**, 2 nouveaux cas confirmés et 16 cas confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 4 nouveaux suspects et 10 suspects en cours de suivi ; 12 résultats annoncés dont 2 positifs, 37 accompagnants et 39 PPL soutenus et 15 membres de ménages soutenus ; 50 guéris attendent toujours leurs kits de déchargement

2.8.2. Défis

Assurer une couverture systématique et précoce des besoins en santé mentale et soutien psychosocial tout au long du parcours de prise en charge, particulièrement pour les nouveaux cas et suspects. Les priorités concernent l'amélioration de la couverture des cas confirmés (63,8 %) et surtout des nouveaux suspects (28,9 %) en Ituri, l'extension de la couverture à l'ensemble des zones de santé concernées à la Tshopo (75,0 %), ainsi que le renforcement de la réinsertion et du suivi communautaire des guéris. Une attention urgente doit également être accordée au Haut-Uélé, où 50 guéris restent en attente de leurs kits de déchargement, afin de favoriser leur réintégration et de réduire les risques de stigmatisation.

2.9. Logistique

2.9.1. Principales actions

- Assurer la mobilité des équipes de la riposte dans toutes les provinces touchées et poursuivre les travaux de construction du CTE de l'HGR de Musienene au Nord-Kivu.

2.9.2. Défi majeur

Garantir une disponibilité continue des moyens logistiques nécessaires à la mobilité et au déploiement rapide des équipes dans l'ensemble des provinces et zones de santé affectées, particulièrement dans les foyers à transmission active et les nouvelles zones touchées. Parallèlement, accélérer l'achèvement et l'opérationnalisation du CTE de l'HGR de Musienene au Nord-Kivu afin de renforcer les capacités locales de prise en charge et de référencement des cas.

2.10. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.10.1. Principales actions

- **En Ituri**, 49 membres du personnel, dont 17 femmes et 32 hommes, ont été briefés sur la PSEAH dans les ZS de Bunia, de Nyankunde, de Nizi et de Rwampara et ont tous signé le code

de bonne conduite ; 255 personnes dont 184 femmes ont été sensibilisées dans la communauté et 3 partenaires (OMS, IRC et Mercy Corps) ont rapporté leurs activités PSEA ;

- **Haut-Uélé** : 4 des 7 zones de santé ont mené des activités PSEA : 40 personnes sensibilisées à Isiro, 26 PRESICODESA à Gombari, 136 chefs d'établissements scolaires à Wamba et 6 personnes à Pawa, 40 codes de bonne conduite ayant été signés ; 6/7 zones de santé connaissent le mécanisme de signalement (85,7 %) ;
- **Au Nord-Kivu**, un briefing a été organisé en faveur de 52 participants, dont 23 hommes et 29 femmes. Dans la Zone de santé Katwa, Aire de santé de Vungi, suivi des consultations communautaires en 4 focus group dont l'un pour les hommes et jeunes, un pour les femmes, un pour les personnes handicapées.

2.10.2. Défis

Étendre et harmoniser la mise en œuvre de la PSEA dans l'ensemble des zones de santé et auprès de tous les acteurs de la riposte, tout en renforçant l'appropriation des mécanismes sûrs et confidentiels de signalement par les communautés et les intervenants. Une attention particulière doit être accordée au Haut-Uélé, où seules 4 des 7 zones de santé rapportent des activités PSEA, ainsi qu'à l'amélioration du rapportage des partenaires en Ituri. Il convient également de poursuivre la signature systématique du code de bonne conduite et de garantir l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap dans les mécanismes de prévention, de consultation et de remontée des plaintes.

2.11. Gestion des bases des données

2.11.1. Principales actions :

- **Poursuite de la collecte, de la compilation, du nettoyage et de la consolidation quotidienne des données** provenant des différentes provinces et des piliers de la riposte, en vue de disposer d'informations actualisées pour l'élaboration du SitRep et la prise de décision ;
- **Poursuite de la saisie et de la mise à jour des données dans le DHIS2**, avec accompagnement des équipes provinciales et des zones de santé pour améliorer la complétude, la promptitude et la qualité des données rapportées ;
- **Renforcement de la vérification de la cohérence des données** entre les différentes sources, notamment les bases de surveillance, laboratoire, prise en charge, vaccination, PCI/EDS et les données consolidées dans le DHIS2, avec identification progressive des doublons, valeurs manquantes et discordances ;
- **Poursuite des travaux d'harmonisation des différentes bases de données utilisées par les piliers et les partenaires**, en vue de promouvoir une base de référence commune et de limiter la fragmentation de l'information ;
- **Renforcement des capacités des équipes de gestion des données**, notamment à travers l'accompagnement des gestionnaires des données et le briefing des prestataires sur la saisie, l'analyse et la visualisation des données dans DHIS2 ;
- **Renforcement de l'analyse intégrée des données de la riposte**, afin de mettre en relation les informations issues de la surveillance, du laboratoire, de la prise en charge, de la PCI/EDS, de la CREC et des autres piliers et de mieux identifier les goulots d'étranglement opérationnels ;
- **Poursuite des échanges avec les piliers et partenaires sur la gouvernance des données**, notamment la clarification des responsabilités en matière de collecte, validation, consolidation, analyse et diffusion des données.

2.11.2. Défi majeur :

Disposer d'une base de données unique, complète, cohérente et régulièrement validée permettant une analyse fiable et intégrée de la riposte. Le défi demeure l'harmonisation des multiples bases actuellement utilisées par les piliers et partenaires, l'amélioration de la complétude et de la qualité des données dans le DHIS2, ainsi que la standardisation du circuit de validation. Il importe également de renforcer les capacités en gestion des données aux niveaux provincial et opérationnel afin que les informations produites permettent d'identifier rapidement les écarts de performance et d'orienter les décisions de l'Incident Management.

MESSAGES CLES

- **La dynamique épidémiologique demeure globalement plus favorable qu'au 11 septembre**, avec **73 nouveaux cas confirmés contre 91 (-19,8 %)**. Cette amélioration est particulièrement marquée au Nord-Kivu. Toutefois, une **remontée de 10,6 % par rapport à la veille** est observée (73 contre 66 cas), principalement portée par l'Ituri.
- **L'extension géographique reste un point de vigilance**, avec la notification d'un premier cas dans la **ZS de Dungu au Haut-Uélé**, frontalière avec le Soudan du Sud. L'Ituri, le Nord-Kivu et le Haut-Uélé demeurent en transmission active, tandis qu'une reprise de cas est observée dans la Tshopo. **Aucun nouveau cas n'a été notifié au Bas-Uélé au cours des dernières 48 heures**, signal favorable à consolider.
- Au cours des dernières 24 heures, **73 nouveaux cas confirmés, 25 décès communautaires et 12 décès intra-CTE** ont été rapportés. Le cumul national s'établit à **7 614 cas confirmés et 3 676 décès, soit une létalité de 48,3 %**. Parallèlement, **41 guérisons ont été enregistrées contre 25 la veille (+64,0 %)**.
- **L'Ituri demeure l'épicentre**, concentrant **77,2 % des cas cumulés et 63,0 % des nouveaux cas du jour**. Les performances de surveillance restent soutenues, avec **100 % des 360 cas suspects investigués** et un suivi des contacts en légère progression, de **87,2 % à 87,8 %**.
- Les priorités opérationnelles immédiates sont de contenir rapidement les foyers actifs, de renforcer la surveillance transfrontalière autour de Dungu avec le Soudan du Sud, d'améliorer la détection précoce et le référencement des cas et de sécuriser les capacités de prise en charge au Nord-Kivu, où les structures normées atteignent 98,2 % d'occupation, tout en intensifiant la PCI/EDS et l'engagement communautaire dans les zones à transmission persistante.
- Renforcer la préparation et réponse à la MVE-B dans les provinces du Corridor fluvial et les zones environnantes.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Système de gestion de l'incident MVE17

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve
E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Incident Manager Adjoint

Professeur Dr Akilimali Zalagile Pierre

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard
Dr KATUSI BISELENGE Jules
Madame MAYELE AFUA Marie
Dr DIUR MANANASHI Floryan
Mr KAMWINA KEBELA John



Contact :

www.sante.gouv.cd
contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151.